

TEMA 9.48 • RESPIRATORIO

Complicaciones de la Amigdalitis Pultácea

PERFIL EUNACOM 1.04.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El tratamiento antibiótico en la **amigdalitis bacteriana** (o pultácea) tiene un rol fundamental. Aunque solo acorta la duración de los síntomas en aproximadamente un día, su objetivo principal es la **prevención de complicaciones**. Gracias al uso sistemático de penicilina o amoxicilina, la incidencia de estas secuelas ha disminuido drásticamente.

Las complicaciones se dividen en dos grandes grupos: **Piógenas** (supurativas) e **Inmunológicas** (no supurativas).

Clasificación de Complicaciones

| TABLA 9.48.1: TIPO VS EJEMPLOS PRINCIPALES |                                                                           |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TIPO                                       | EJEMPLOS PRINCIPALES                                                      | OTRAS                             |
| <b>Piógenas (Abscesos)</b>                 | Absceso periamigdalino, Parafaríngeo, Retrofaríngeo.                      | Mediastinitis aguda.              |
| <b>Inmunológicas</b>                       | <b>Glomerulonefritis</b><br><b>Postestreptocócica</b> , Fiebre Reumática. | Eritema nodoso, Psoriasis gutata. |

NOTA CLÍNICA

Las complicaciones inmunológicas ocurren por una respuesta aberrante del sistema inmune tras la infección por *Streptococcus pyogenes* (Streptococcus grupo A), no por la invasión directa de la bacteria en esos órganos.

Complicaciones Piógenas (Abscesos de Cuello)

Son colecciones de pus que se forman en los espacios profundos de la cabeza y el cuello. El diagnóstico de sospecha es **fundamentalmente clínico**.

1. Absceso Periamigdalino

Es la complicación piógena **más frecuente**. - **Clínica**: Odinofagia intensa (unilateral habitualmente), voz de "papa caliente". - **Signo cardinal: Trismus** (dificultad para abrir la boca por compromiso del músculo pterigoideo). - **Examen físico**: Abombamiento del pilar amigdalino anterior y desplazamiento de la úvula hacia el lado contralateral.

2. Absceso Parafaríngeo

Se ubica lateral a la faringe. - **Clínica**: Aumento de volumen evidente en la cara y zona lateral del cuello, bajo el ángulo de la mandíbula. - **Signo sugerente**: Dolor intenso con los **movimientos laterales** del cuello.

3. Absceso Retrofaríngeo

Se ubica en el espacio entre la faringe y la columna vertebral. Es una **emergencia médica**. - **Clínica**: Dolor con los movimientos **anteroposteriores** del cuello. - **Riesgo vital**: Puede comprimir la vía aérea (tráquea) desplazándola hacia adelante, provocando estridor y disnea.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El absceso retrofaríngeo es una urgencia de alto riesgo vital por la potencial obstrucción de la vía aérea superior. Requiere manejo inmediato por especialista.

Mediastinitis Aguda: La Complicación más Grave

Ocurre cuando la infección de los espacios profundos del cuello desciende por continuidad hacia el tórax, infectando el mediastino.

- Clínica**: Dolor torácico retroesternal, fiebre alta y signos de **sepsis** rápida evolución.

- Gravedad**: Tiene una altísima mortalidad si no se trata de forma agresiva.

Diagnóstico y Manejo de los Abscesos

Aunque la sospecha es clínica, el estudio de imágenes es vital para la planificación.

Estudio de Imágenes

1. **TAC de Cuello con contraste**: Es el examen de elección. Permite ver la anatomía, confirmar la presencia de la colección y diferenciar un flegmón (inflamación de partes blandas) de un absceso (colección drenable). 2. **TAC de Tórax**: Se solicita si existe sospecha clínica de **mediastinitis**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, recuerda que el TAC sirve principalmente para ver la extensión anatómica y guiar el abordaje quirúrgico, pero no debe retrasar el manejo de la vía aérea si esta se ve comprometida.

Tratamiento

El manejo es hospitalizado y multidisciplinario:

- Drenaje Quirúrgico**: Es el pilar del tratamiento. Debe realizarse en pabellón para evacuar el pus. En la mediastinitis, se requiere aseo quirúrgico del mediastino.
- Antibioticoterapia de Amplio Espectro**: Estas infecciones suelen ser **polimicrobianas** (Gram positivos, Gram negativos y anaerobios).
  - Esquema habitual: **Ceftriaxone** (cubre Streptococos y Gram negativos) + **Clindamicina** (excelente cobertura para anaerobios y Gram positivos como Staphylococcus).

Resumen de Hallazgos Clínicos

| TABLA 9.48.2: HALLAZGO VS SOSPECHA CLÍNICA |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| HALLAZGO                                   | SOSPECHA CLÍNICA       |
| <b>Trismus</b>                             | Absceso Periamigdalino |
| <b>Desplazamiento de úvula</b>             | Absceso Periamigdalino |
| <b>Dolor al mover cuello lateralmente</b>  | Absceso Parafaríngeo   |
| <b>Compresión de vía aérea / Dolor AP</b>  | Absceso Retrofaríngeo  |
| <b>Dolor torácico + Sepsis</b>             | Mediastinitis Aguda    |

NOTA CLÍNICA

En la radiografía lateral de cuello para absceso retrofaríngeo, se observa un **aumento del espacio prevertebral** (distancia entre las vértebras y la columna de aire de la tráquea).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 22 años con antecedente de amigdalitis pultácea hace 5 días, actualmente con odinofagia severa, imposibilidad de abrir la boca y babeo. Al examen se observa abombamiento del pilar amigdalino derecho hacia la línea media. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Complicaciones de la Amigdalitis Pultácea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- El antibiótico en amigdalitis bacteriana apenas acorta la enfermedad (~1 día), pero previene las complicaciones.
- Complicaciones piógenas: absceso periamigdalino (más frecuente), parafaríngeo, retrofaríngeo y mediastinitis (más grave).
- Complicaciones inmunológicas: glomerulonefritis aguda postestreptocócica, enfermedad reumática, eritema nodoso, psoriasis gutata.
- Absceso periamigdalino: odinofagia muy intensa + trismus + abombamiento del pilar amigdalino hacia medial.
- Absceso parafaríngeo: aumento de volumen facial/cervical + dolor a movimientos LATERALES del cuello.
- Absceso retrofaríngeo: dolor a movimientos ANTEROPOSTERIORES + compresión de tráquea (urgencia vital).
- Mediastinitis: dolor torácico + sepsis. Es la complicación más grave.
- Diagnóstico: clínico + TAC de cuello (+ tórax si sospecha mediastinitis) para planificación quirúrgica.
- Tratamiento: drenaje quirúrgico + antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona + clindamicina) por ser polimicrobianos.
- En mediastinitis: drenaje + aseo quirúrgico del mediastino. TAC de tórax es el examen de elección para evaluar mediastino.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES DE LA AMIGDALITIS PULTÁCEA)****PREGUNTA 1**

Paciente de 22 años con antecedente de amigdalitis pultácea hace 5 días, actualmente con odinofagia severa, imposibilidad de abrir la boca y babeo. Al examen se observa abombamiento del pilar amigdalino derecho hacia la línea media. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial?

- A)** Absceso periamigdalino; TAC de cuello y drenaje quirúrgico con antibióticos de amplio espectro
- B)** Absceso retrofaríngeo; intubación de emergencia y drenaje quirúrgico
- C)** Amigdalitis pultácea refractaria; cambiar a amoxicilina-ácido clavulánico
- D)** Mononucleosis complicada; solicitar monotest y hemograma
- E)** Mediastinitis; TAC de tórax urgente y cirugía torácica

**PREGUNTA 2**

Paciente de 30 años con amigdalitis tratada con amoxicilina hace 7 días, ahora con fiebre alta, dolor cervical intenso que aumenta con la extensión y flexión del cuello, y estridor inspiratorio. La radiografía lateral de cuello muestra aumento del espacio prevertebral con desplazamiento anterior de la tráquea. ¿Cuál es la complicación más probable?

- A)** Absceso periamigdalino
- B)** Absceso parafaríngeo
- C)** Absceso retrofaríngeo
- D)** Mediastinitis aguda
- E)** Epiglotitis aguda

**PREGUNTA 3**

Respecto a las complicaciones de la amigdalitis bacteriana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A)** El principal objetivo del tratamiento antibiótico es acortar la duración de los síntomas
- B)** La glomerulonefritis aguda postestreptocócica es una complicación piógena
- C)** El absceso periamigdalino es la complicación más frecuente y la mediastinitis la más grave
- D)** Los abscesos faríngeos se tratan exclusivamente con antibióticos endovenosos sin necesidad de drenaje
- E)** El TAC de cuello es indispensable para el diagnóstico del absceso periamigdalino

**RESUMEN: COMPLICACIONES DE LA AMIGDALITIS PULTÁCEA**

Las complicaciones de la amigdalitis bacteriana se dividen en dos grandes grupos: piógenas (abscesos) e inmunológicas. El tratamiento antibiótico apenas acorta la enfermedad en un día aproximadamente, pero su verdadera utilidad es prevenir estas complicaciones. Gracias al uso actual de antibióticos, las complicaciones son mucho menos frecuentes que en el pasado. Las complicaciones piógenas incluyen el absceso periamigdalino (la complicación más frecuente de la amigdalitis bacteriana), el absceso parafaríngeo, el absceso retrofaríngeo y la mediastinitis aguda (la más grave). El absceso periamigdalino se manifiesta con odinofagia muy intensa, trismus y abombamiento del pilar amigdalino hacia medial. El absceso parafaríngeo presenta aumento de volumen facial y cervical con dolor a los movimientos laterales del cuello. El absceso retrofaríngeo produce dolor a los movimientos anteroposteriores y puede comprimir la tráquea, desplazándola hacia adelante, constituyendo una urgencia vital. La mediastinitis se presenta con dolor torácico y síntomas de sepsis. Las complicaciones inmunológicas más importantes son la glomerulonefritis aguda postestreptocócica y la enfermedad reumática, además del eritema nodoso y la psoriasis gutata. El diagnóstico de los abscesos es fundamentalmente clínico, pero se complementa con TAC de cuello (y tórax si se sospecha mediastinitis) para planificar el abordaje quirúrgico. El tratamiento es drenaje quirúrgico más antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona + clindamicina), ya que suelen ser polimicrobianos. En la mediastinitis se requiere además aseo quirúrgico del mediastino.